

ARTRITIS POR MICROCRISTALES

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Las artritis por microcristales son un conjunto de enfermedades producidas por el depósito de cristales de diferente composición química en las articulaciones y en los tejidos blandos. Son uno de los principales motivos de consulta en Urgencias debido al intenso dolor que generan; siendo su máximo representante, la gota.

DIAGNÓSTICO

Clasificación

- Gota: Por acúmulo de cristales de ácido úrico.
- Pseudogota/Condrocalcinosis: Por acumulo de cristales de pirofosfato cálcico.
- Artropatía por depósito de hidroxapatita cálcica.
- Artropatía por depósito de oxalato cálcico.
- Otras: Cristales de corticoides (tras infiltraciones); Cristales lipídico (en artritis reumatoide, espondiloartropatías) o cristales proteicos (en mieloma múltiple o crioglobulinemia)

Clínica

Lo más frecuente es que debuten en forma de monoartritis muy dolorosa (aunque pueden presentarse ya sea en debut o en evolución como oligo/poliartritis) de manera esporádica o tras un incidente intercurrente (como infecciones, traumatismos, cirugías, enfermedades...) en cualquier localización (aunque cada uno de los tipos tiene un lugar preferente de afectación). Pueden asociar febrícula o fiebre en alguna ocasión.

En casos de gota muy crónicos o en errores diagnósticos/terapéuticos podemos encontrarnos tofos (depósito de cristales de ácido úrico) en distintas localizaciones (tejidos blandos, cartílagos...), que en general, tienden a disminuir de tamaño con el tratamiento adecuado.

Pruebas complementarias

Ante toda monoartritis hemos de realizar punción y análisis del líquido sinovial;

valorando aspecto macroscópico-bioquímica-recuento-fórmula leucocitaria-búsqueda de cristales. Es la artrocentesis la que nos dará en la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico definitivo de esta entidad y poder diferenciar los grandes tipos en función del cristal que hallemos en el líquido sinovial.

A nivel analítico, suelen presentar elevación de reactantes de fase aguda (PCR/VSG) así como leucocitosis aunque no tan elevadas como las que esperaríamos encontrar en una artritis séptica. Es importante tener en cuenta que durante una crisis aguda de gota no tiene sentido medir los niveles de ácido úrico puesto que pueden estar normales.

En caso de realizar radiografías, se podría visualizar destrucción articular (mayor en gota) y condrocalcinosis (más evidente en pseudogota).

Diagnostico diferencial

	GOTA	Pseudog	HA	OC
Cristal	Urato monosódico	Pirofosfato cálcico	Hidroxi. Cálcica	Oxalato Cálcico
Birrefing.	Fuerte	Débil	-	Intensa
Forma	Aguja	Romboidal	Pequeño	Bipiramidal
Lugar preferen.	1era MTF pie	Rodilla	Hombro	Cualquiera

Birrefin: Birrefringencia; Preferen: Preferente HA: Hidroxiapatita cálcica; OC: Oxalato cálcico; Pseudog: Pseudogota

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- En caso de dudas diagnosticas.
- Refractariedad al tratamiento.

TRATAMIENTOGota

Durante el **ataque agudo**:

- AINE: Ibuprofeno 600 mg c/8 h; Naproxeno 500 mg c/12 h o Dexketoprofeno 25 mg c/8h.
- Colchicina: 1 mg/ día durante 4 días. En la gota, se mantiene 6 meses.
- Corticoides: Pauta descendente durante 10 días (2,5-7,5 mg/día). Infiltraciones también son útiles.
- Tetracosáctido: Análogo de GH que estimula la producción endógena de corticoides. Se administraría 1 mg por vía IV (solamente uso hospitalario en casos refractarios).
- No iniciar tratamiento hipouricemiante hasta superar el ataque agudo.
- No suspender el tratamieto que el paciente tome de base.

Por otro lado, la hiperuricemia asintomática ($>6-7$ mg/dl ácido urico) en principio no debe ser tratada. Sin embargo, EULAR/ACR recomiendan iniciar tratamiento si:

- Existen tofos.
- Hay afectación poliarticular o daño articular estructural.
- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Pacientes muy jóvenes.
- Si la uricemia se mantiene elevada a lo largo del tiempo por el riesgo cardiovascular que implica.

Se utilizan sobre todo, inhibidores de la xantina oxidasa (disminuyendo así la producción endógena de ácido úrico) como son:

- Alopurinol: Iniciamos a dosis de 100 mg/día (excepto en ERC donde daremos 1 mg por ml/min de FG) hasta un máximo de 300 mg/día. Precaución en la combinación con diuréticos.
- Fexobustat: Iniciamos a dosis de 80 mg/día pudiendo elevarse hasta 120 mg/día. Contraindicado en cardiopatía isquémica.

Es importante que el tratamiento de base no sea suspendido durante ingresos dado que puede incrementar el riesgo de sufrir un ataque agudo de gota. Al inicio del tratamiento podríamos administrar colchicina (1mg/día) a fin de prevenir ataques agudos de gota siempre que no existe

ERC o enfermedad hepática severa.

Otras artritis por microcristales

Durante el ataque agudo: (Similar al de la gota)

- AINE: Ibuprofeno 600 mg c/8h; naproxeno 500 mg c/12h, indometacina 25-50 mg/día.
- Colchicina: Menos eficacia que en la gota. 1 mg/día.
- Corticoides: Pauta descendente. Podrían ser útiles las infiltraciones.

NOTA

- En general, las artritis por microcristales suelen presentarse como monoartritis muy dolorosas que requieren de artrocentesis e inicio de tratamiento antiinflamatorio de inmediato.

BIBLIOGRAFÍA

- Pascual Gomez, E. Artritis por microcristales. Epidemiología y patogenia. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 94: 569-573.
- Pérez Ruiz, F. Gota. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 95: 574-579.
- Andrés Collado, M. Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018: 96: 580-583.
- Calvo Aranda, E. Enfermedad por depósito de hidroxapatita. Otras artritis por microcristales. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018: 97: 584-587.

ARTRITIS REUMATOIDE

Boris A. Blanco-Cáceres, Fernando Lozano, Sandra P. Chinchilla

INTRODUCCIÓN

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a cualquier órgano, pero tiene especial predilección por el aparato locomotor. Suele afectar más a menudo a mujeres de mediana edad.

El abordaje terapéutico ha cambiado mucho en la última década con el objeto de controlar la inflamación articular y de esta forma disminuir el daño estructural y la discapacidad asociada.

El tratamiento de la AR se basa en terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras que buscan controlar la inflamación. En algunas ocasiones estos pacientes presentan brotes de la enfermedad o acontecimientos adversos derivados del tratamiento, demandando consulta en los servicios de urgencias.

A continuación mencionaremos algunas de las complicaciones más frecuentes y el abordaje sugerido en urgencias. Es importante tener en cuenta que ante cualquier evento que suponga actividad de la enfermedad se debe remitir al paciente a su reumatólogo habitual para completar el manejo terapéutico y el ajuste del tratamiento de fondo si fuera necesario.

MANIFESTACIONES ARTICULARES

Monoartritis

A pesar de la naturaleza poliarticular de la AR, en ocasiones los pacientes consultan por sintomatología monoarticular sobre articulación nativa. En estos casos, en primer lugar se debe descartar el origen infeccioso por el riesgo que supone. Las articulaciones más afectadas suelen ser rodillas y hombros.

Anamnesis

Preguntar por síntomas sistémicos como fiebre, tiritona o malestar general. La afectación articular puede llegar a limitar las actividades cotidianas. El dolor es característicamente inflamatorio y persiste en reposo. Averiguar el tiempo de evolución de la sintomatología, precipitantes como abandono de la medicación, (El abandono de la medicación te haría sospechar un brote de la AR monoarticular, pero no una artritis infecciosa) traumatismo, heridas, instrumentación oral, digestiva, o urinaria recientes.

Exploración Física

La articulación comprometida estará tumefacta, caliente y eritematosa, con importante limitación funcional para los movimientos activos y pasivos. Buscar soluciones de continuidad cutáneas (a menudo presentes en compromiso de articulaciones en zonas de apoyo).

Pruebas Complementarias

- Siempre que sea posible se debe obtener muestra del líquido sinovial (LS) mediante artrocentesis. Cursar análisis del LS (glucosa, proteínas y celularidad), enviar muestra a Microbiología.
- Solicitar analítica general con reactantes de fase aguda (PCR, VSG).
- Radiografía de la articulación afectada.
 - Si se sospecha causa infecciosa solicitar hemocultivos y urocultivos previos al inicio del tratamiento antibiótico, incluso en ausencia de fiebre.

Tratamiento En El Servicio De Urgencias

En los casos en los que la artritis sea sugerente de brote inflamatorio pautar corticoides orales o parenterales (<30 mg/día de prednisona en dosis descendentes) y asociar AINEs si el perfil del paciente lo permite (no aconsejados en pacientes mayores o con enfermedad renal). La dosis debe ser individualizada, articulaciones pequeñas podrían beneficiarse de dosis < 15 mg/día. La infiltración local de corticoide con anestésico (P.ej. acetónido de triamcinolona 40mg + Lidocaína) es una opción viable y de fácil acceso en articulaciones grandes como la rodilla o el hombro.

Si la sospecha infecciosa es alta, iniciar tratamiento antibiótico empírico con cobertura para gram positivos y gram negativos, en función del perfil de cada paciente (P. ej.: Cloxacilina + Ceftriaxona). Solicitar ingreso hospitalario para continuar tratamiento parenteral.

Cuando un paciente reciba tratamiento con Fármacos modificadores de la enfermedad (FAMES) convencional o biológico este siempre debe suspenderse de forma temporal y comunicar al reumatólogo habitual. Es importante verificar la medicación que el paciente viene tomando.

Brote poliarticular

Cuando un paciente acude por artritis en cuatro o más articulaciones hablamos de un brote poliarticular. En esta situación el paciente presenta incapacidad funcional afectando claramente su calidad de vida. Estos pacientes probablemente requieran un ajuste del tratamiento por parte de su reumatólogo.

Anamnesis

Preguntar por síntomas sistémicos como fiebre, tiritona o malestar general. En un brote poliarticular los pacientes se ven incapacitados para tareas cotidianas básicas como vestirse o peinarse, esto nos orientará sobre la gravedad del cuadro. Averiguar el tiempo de evolución de la sintomatología y precipitantes como abandono de la medicación o infecciones recientes.

Exploración Física

Las articulaciones comprometidas estarán tumefactas, calientes y eritematosas, asocian limitación funcional para los movimientos activos y pasivos. Las articulaciones que se afectan con más frecuencia son las pequeñas (manos o pies), hombros y rodillas. Es de ayuda para el manejo posterior, reseñarenla historia el número de articulaciones tumefactas y dolorosas.

Pruebas Complementarias:

- Solicitar analítica general con hematimetría y reactantes de fase aguda (PCR, VSG).
- De encontrarse elevados los reactantes de fase aguda, descartar otras posibles causas como infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, etc.

Tratamiento En El Servicio De Urgencias

Los pacientes se beneficiarán de corticoides orales o parenterales en función de la afectación, no existen pautas establecidas pero se puede pautar corticoide parenteral y luego oral (equivalente a <30 mg/día Prednisona, en pauta descendente) hasta control por su reumatólogo. El número de articulaciones comprometidas y el tamaño de estas orientará a la pauta de corticoides a utilizar, en el caso de las articulaciones pequeñas en general se controlan con <15 mg/día en pauta descendente. Aquellos casos con importante compromiso funcional, sistémico y afectación de grandes y pequeñas articulaciones podrían beneficiarse de una dosis parenteral de corticoides y al alta corticoides orales <30 mg/día en pauta descendente hasta control por Reumatología. Se pueden asociar AINEs si el perfil del paciente lo permite.

MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES

A continuación reseñamos algunas manifestaciones que se pueden presentar en pacientes con AR.

Cutáneas

- Nódulos reumatoides en zonas de roce, no precisan tratamiento urgente.
- Reacción psoriasiforme en pacientes con tratamiento biológico (antiTNF), suspender tratamiento y solicitar valoración por Reumatología.
- Púrpura, pioderma gangrenoso, en relación a vasculitis reumatoidea.
- Fenómeno de Raynaud.

Oculares

Queratoconjuntivitis seca, Epiescleritis (ojo rojo no doloroso), Escleritis (ojo rojo doloroso y fotofobia). Requieren valoración por Oftalmología si: Disminución de agudeza visual, dolor ocular moderado-severo, primer episodio de ojo rojo doloroso con empeoramiento progresivo.

Pulmonar

Pueden estar asociadas a la propia enfermedad, infecciones intercurrentes o al tratamiento empleado.

Compromiso pleural

Pleuritis, líquido pleural con características de exudado, poca celularidad, LDH y ADA elevados, FR positivo. En general no requieren tratamiento salvo el de la enfermedad de base, se debe individualizar. Es importante descartar otras causas como la cardiogénica.

Enfermedad pulmonar intersticial

Curso clínico variable, desde asintomática hasta rápidamente progresiva con necesidad de soporte e ingreso hospitalario. Radiográficamente presenta patrón retículo-nodular.

Cardiovascular

La AR es un factor independiente de riesgo cardiovascular por lo que los eventos cardiovasculares están incrementados en estos pacientes.

Pericarditis: Pueden presentar derrame pericárdico, la mayoría de forma asintomática, raramente evolucionan a taponamiento cardíaco. Requiere manejo conjunto Reumatología - Cardiología.

Hematológicas

Los pacientes presentan anemia de trastornos crónicos y trombocitosis en relación al proceso inflamatorio de base. Sd. Felty cursa con neutropenia, esplenomegalia, en un/a paciente con AR seropositiva de larga evolución.

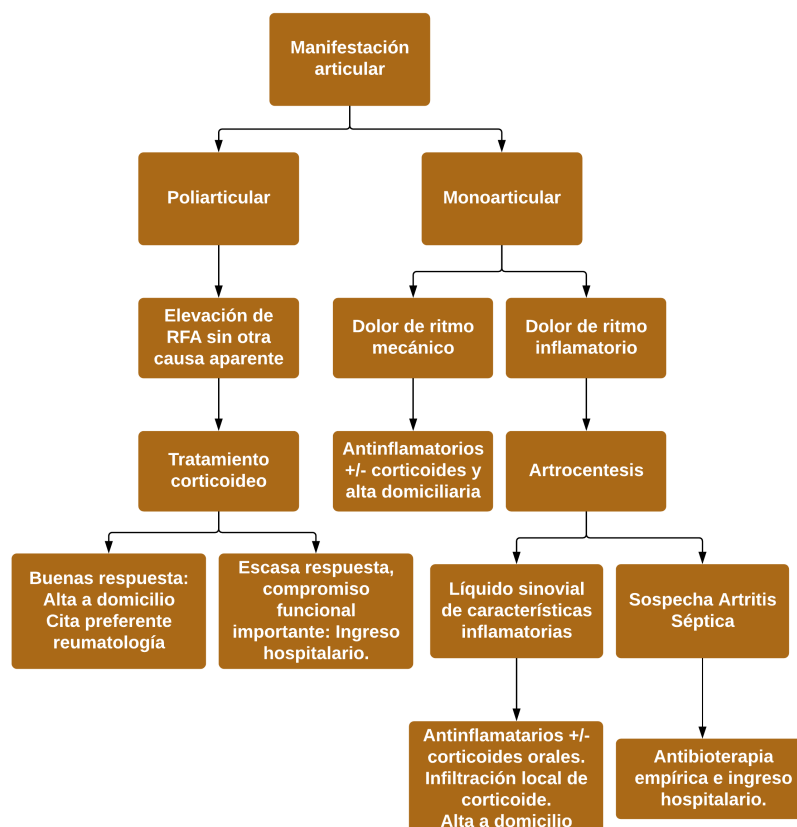
No olvidar efectos adversos de los medicamentos, en especial en aquellos pacientes que presenten deterioro agudo de la función renal ya que algunos fármacos modificadores de la enfermedad pueden producir citopenias por toxicidad.

Infecciones

Los pacientes con AR y otras enfermedades inflamatorias/autoinmunes tienen un riesgo aumentado de infecciones bacterianas como neumonía, infecciones de piel y partes blandas, entre otras que pueden comprometer la vida. El tratamiento de base que se emplea en la AR (Glucocorticoides, FAMEs biológicos y sintéticos) incrementa este riesgo, y en muchos casos las infecciones cursan de forma paucisintomática y con poca expresividad sistémica. De constatarse

un proceso infeccioso el tratamiento con FAMEs debe ser suspendido, pudiendo mantener el tratamiento con corticoides a dosis bajas. Es importante informar al especialista en Reumatología sobre la suspensión del tratamiento. Ante todo primará la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente.

MANIFESTACIONES ARTICULARES



BIBLIOGRAFÍA

- Alperi López M. Artritis Reumatoide. Clínica y Diagnóstico. En: Tornero J, Blanco Garcia FJ, Directores. Tratado de enfermedades Reumáticas de la SER. España: Editorial Panamericana; 2018. p. 399-406.
- Bouros D, Pneumatikos I, Tzouvelekis A. Pleural involvement in systemic autoimmune disorders. Respiration 2008; 75:361
- Turesson C, O'Fallon WM, Crowson CS, Gabriel SE, Matteson EL. Extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis: incidence trends and risk factors over 46 years. Ann Rheum Dis. 2003;62(8):722.
- Guedes C, Bianchi-Fior P, Cormier B, Barthelemy B, Rat AC, Boissier MC. Cardiac manifestations of rheumatoid arthritis: a case-control transesophageal echocardiography study in 30 patients. Arthritis Rheum. 2001;45(2):129.
- Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JW, Breedveld FC, Boumpas D, Burmester G, Combe B, Cutolo M, de Wit M, Dougados M, Emery P, Gibofsky A, Gomez-Reino JJ, Haraoui B, Kalden J, Keystone EC, Kvien TK, McInnes I, Martin-Mola E, Montecucco C, Schoels M, van der Heijde D, T2T Expert Committee. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2010;69(4):631. Epub 2010 Mar 9.
- Doran MF, Crowson CS, Pond GR, O'Fallon WM, Gabriel SE. Frequency of infection in

patients with rheumatoid arthritis compared with controls: a population-based study. Arthritis Rheum. 2002;46(9):2287.

FENÓMENO DE RAYNAUD

Fernando Lozano, Boris A. Blanco Cáceres, Miriam Retuerto Guerrero

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Raynaud consiste en episodios paroxísticos reversibles de vasoconstricción periférica, típicamente en los dedos de manos y pies, en respuesta a determinados estímulos, ya sean físicos (exposición al frío), mecánicos (compresión, vibración), químicos (fármacos vasoconstrictores) o emocionales (estrés), aunque también pueden producirse espontáneamente.

La prevalencia de este fenómeno es de un 3-5% de la población general, con un predominio en el sexo femenino (7:1). La forma de presentación clásica consiste en cambios en la coloración de los dedos en tres fases secuenciales: palidez (fase de isquemia), cianosis (fase de hipoxia) y eritema (fase de reperfusión), aunque no siempre aparecen las tres fases (lo más frecuente es que sea bifásico). Los episodios se pueden acompañar de síntomas como sensación de frialdad, parestesias y dolor en la zona afecta, y su duración puede variar de minutos a horas.



El fenómeno de Raynaud puede ser primario, cuando aparece de forma aislada sin evidencia de ninguna enfermedad subyacente, o secundario, cuando se asocia a otra condición. Las enfermedades subyacentes más frecuentes son las conectivopatías autoinmunes, principalmente la esclerosis sistémica (95%), aunque también se asocia a las miopatías inflamatorias, la enfermedad mixta del tejido conectivo o el lupus eritematoso sistémico entre otras. También puede asociarse a vasculitis, tromboangeítis obliterante o enfermedad de Buerger, aterosclerosis, tumores sólidos o hematológicos, trastornos neurológicos o endocrinos (hipotiroidismo).

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Debe recoger datos en relación con la forma de presentación y distribución del fenómeno de Raynaud, factores desencadenantes, edad de inicio del mismo y antecedentes familiares. El fenómeno de Raynaud primario suele debutar generalmente antes de los 30 años, tiende a tener un carácter simétrico, y los episodios suelen ser menos frecuentes, duraderos e intensos que en

el caso del secundario, además de más frecuentemente asintomáticos (sin dolor asociado). Habitualmente existe asociación familiar (entre un 30-50% de los pacientes con fenómeno de Raynaud primario tienen un familiar de primer grado afecto). En el caso del secundario, la afectación del pulgar se produce con mayor frecuencia.

La anamnesis debe ir además dirigida a la búsqueda de signos y síntomas de enfermedad autoinmune: artralgias inflamatorias o artritis, rigidez matutina, mialgias, síntomas secos, fiebre, clínica constitucional, lesiones cutáneas, signos y síntomas de enfermedad cardíaca o respiratoria, dismotilidad esofágica, etc.

Además, es importante recoger un posible antecedente de consumo de fármacos o exposición a agentes tóxicos predisponentes (betabloqueantes, ergotamina, fármacos y drogas simpaticomiméticas, quimioterápicos como el cisplatino o la bleomicina, inhibidores de tirosina kinasas, etc.).

Examen físico

Debe dirigirse a la detección de datos de enfermedad autoinmune: edema de dedos o de manos, esclerodactilia, úlceras o cicatrices puntiformes en los dedos, telangiectasias, calcinosis, eritema periungueal, debilidad muscular, etc. Debe prestarse igualmente atención a la presencia de datos de enfermedad vascular: asimetría o ausencia de pulsos periféricos, asimetría en la medición de la tensión arterial en ambas extremidades, evidencia de lesiones tróficas con necrosis, úlceras y gangrena.

Pruebas complementarias

Aunque en general no disponible de forma urgente, el estudio básico del fenómeno de Raynaud ha de incluir una determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) y una capilaroscopia, que siempre serán normales en el caso de un fenómeno de Raynaud primario pero pueden estar alterados en el secundario. Las alteraciones en la capilaroscopia (zonas de ausencias capilares, presencia de capilares dilatados, hemorragias) constituyen el mejor predictor de desarrollo de enfermedad subyacente.

Si se sospecha fenómeno de Raynaud secundario, se debe realizar un estudio analítico en función de los síntomas del paciente y de los hallazgos de la exploración (reactantes de fase aguda, hemograma, perfil hepático y renal, análisis de orina, electroforesis de proteínas séricas, niveles de complemento, etc.). En caso de sospecha de vasculopatía puede solicitarse un estudio de imagen vascular como ecografía Doppler, angio-TC o angio-RMN.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas higienicodietéticas

Constituyen las primeras medidas que deben recomendarse siempre en el manejo del fenómeno de Raynaud. En muchos casos primarios, dichas medidas son suficientes para mantener un adecuado control sintomático y una buena calidad de vida, aunque los pacientes con fenómeno de Raynaud secundario suelen precisar medidas farmacológicas. Consisten en:

- Evitar la exposición al frío (no sólo de las zonas afectas, sino del cuerpo completo), así como los cambios bruscos de temperatura.
- Evitar la exposición ocupacional a factores físicos desencadenantes (traumatismos repetidos, vibración), además del estrés emocional.
- Evitar el hábito tabáquico, así como la exposición a fármacos vasoconstrictores

(betabloqueantes, antimigrañosos, agentes simpaticomiméticos, etc.).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos

Constituyen la primera línea de tratamiento médico. Disminuyen el número y la intensidad de los ataques. Los más utilizados son el nifedipino (a dosis inicial de 10 mg cada 8h) y el amlodipino (a dosis inicial de 5 mg al día), pudiendo aumentarse la dosis progresivamente según la aparición de efectos adversos como mareo y cefalea, hasta 60 mg cada 8h el nifedipino y 10 mg cada 12h el amlodipino.

En caso de mala respuesta o tolerancia a los anteriores, otras alternativas son los **antagonistas de los receptores de angiotensina II** (losartán a dosis de 25-100 mg/día) o los **antagonistas de receptores adrenérgicos alfa-1** (prazosina a dosis de 1-5 mg/día).

En caso de refractariedad a los fármacos anteriores, se pueden utilizar vasodilatadores más potentes:

Análogos intravenosos de la prostaciclina

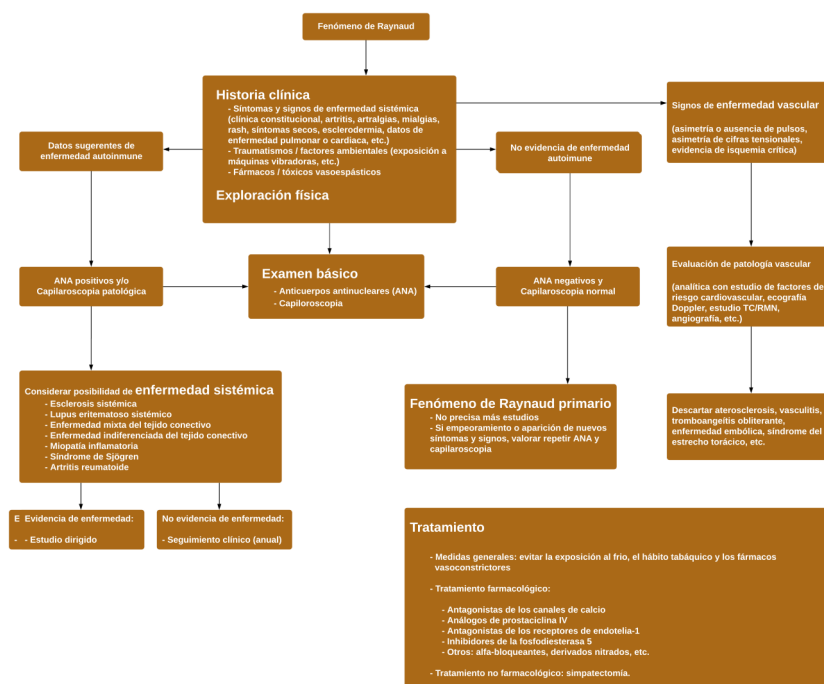
Indicados en el fenómeno de Raynaud severo con lesiones isquémicas secundarias (siempre en el contexto de enfermedad autoinmune subyacente, como la esclerosis sistémica). Habitualmente se utilizan en ciclos cada 4-6 semanas. El más utilizado es el iloprost, a dosis inicial de 0.5-2 ng/kg/min, que se va aumentando según tolerancia, durante al menos 6h al día, de 2 a 5 días consecutivos. Los efectos adversos más frecuentes son la aparición de cefalea, náuseas y vómitos.

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5

(PDE-5) como el sildenafil (dosis inicial de 20 mg/12h, hasta 40 mg/8h), tadalafil (20-40 mg/día) y vardenafil (10 mg/12h).

Antagonistas de receptor de endotelina I

Indicados en la prevención secundaria de las úlceras isquémicas en pacientes con esclerosis sistémica. El más utilizado es el bosentán, a dosis de 125 mg/12h.



BIBLIOGRAFÍA

- Linnemann B, Erbe M. Raynaud's phenomenon – assessment and differential diagnoses. Vasa 2015; 44: 166-177.
- Prete M, Fatone MC, Favoino E, Perosa F. Raynaud's phenomenon: from molecular pathogenesis to therapy. Autoimmun Rev 2014; 13: 655-667.
- Roustit M, Khouri C, Blaise S, Villier C, Carpentier P, Cracowski JL. Pharmacology of Raynaud's phenomenon. Therapie 2014; 69(2): 115-128.
- Kuryliszyn-Moskal A, Kita J, Hryniewicz A. Raynaud's phenomenon: new aspects of pathogenesis and the role of nailfold videocapillaroscopy. Reumatologia 2015; 53(2): 87-93.
- Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud's phenomenon. N Engl J Med 2016; 375: 556-565.
- Maverakis E, Patel F, Kronenberg DG, Chung L, Fiorentino D, Allanore Y, et al. International consensus criteria for the diagnosis of Raynaud's phenomenon. J Autoimmun 2014; 0:60-65.

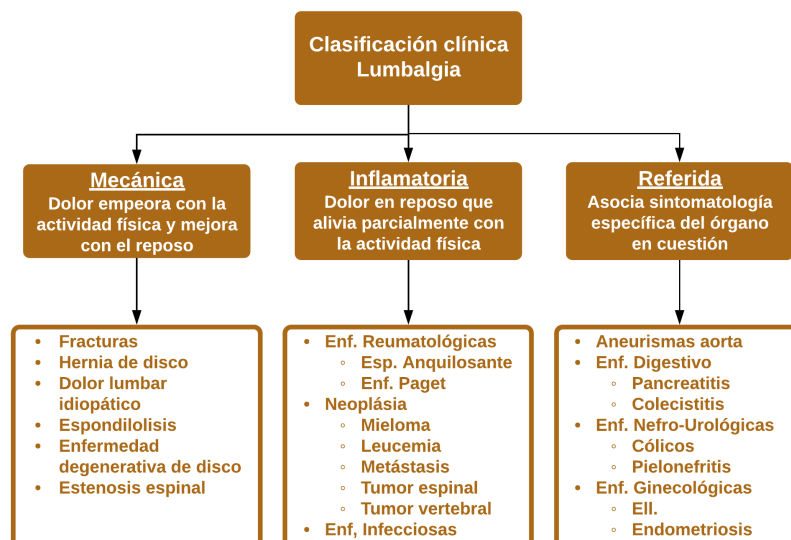
LUMBALGIA

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Dolor localizado en el dorso del cuerpo que se extiende desde la última costilla hasta la zona glútea y que puede irradiarse por el miembro inferior con una prevalencia del 80%.

Clasificación clínica de lumbalgia.



Clasificación según cronología

Aguda: Menos de seis semanas de duración.

Subaguda: Entre seis y doce semanas de duración.

Crónica: Más de doce semanas de duración.

DIAGNÓSTICO

Fundamentalmente clínico, aunque, cerca del 80% de las lumbalgias presentan hallazgos inespecíficos que no permiten llegar a una etiología concreta. La mayoría de las lumbalgias tienen un curso autolimitado en el tiempo (4-6 semanas) y son de naturaleza benigna.

Exploración física

- Inspección: Estática del raquis, equilibrio hombros, miembros, crestas ilíacas y glúteos, valoración de la marcha, valoración de la movilidad lumbar.
- Palpación: De apófisis espinosas, musculatura paravertebral.
- Examen neuromuscular:
- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

Analítica: Hemograma, bioquímica básica con reactantes de fase aguda y sistemático de orina.

Radiología simple: **No de rutina**. En general, indicada si sospechamos enfermedad sistémica, para descartar alteraciones estructurales importantes o si no hay mejoría tras 2-4 semanas de tratamiento conservador.

Otras pruebas de imagen (TAC/RMN): Según sospecha diagnóstica.

Datos de alarma

ENFERMEDAD SISTÉMICA	PARA VALORACIÓN POR CIRUGÍA
Lumbalgia inflamatoria.	Paresia progresiva o bilateral.
Primer episodio en <20 y >50 años.	Pérdida de control de esfínteres de origen neurológico.
Déficit neurológico difuso.	Anestesia en silla de montar
Síndrome constitucional/ Inmunosupresión. Uso de corticoides y/o tóxicos por vía parenteral.	Dolor radicular que persiste $\geq$ 6 semanas a pesar de tratamiento conservador (Probable hernia discal)
Antecedente de traumatismo/neoplasia/ manipulación instrumental.	Dolor radicular que requiere flexión/ extensión para desaparecer a pesar de 6 meses de tratamiento conservador.

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- Lumbalgia inflamatoria sin causa conocida a estudio.
- Lumbalgia mecánica que asocie clínica neurológica.
- Lumbalgia donde el tratamiento médico correcto haya fracasado para adecuado control del dolor.

TRATAMIENTO

Lumbalgia mecánica

Sin Compromiso Neurológico

Iniciamos con actitud conservadora como calor local (disminuye el espasmo), fisioterapia y reposo relativo con las que la mayoría remiten en 4-6 semanas. Si no respuesta, recurrimos a fármacos como analgésicos (paracetamol 650-1000 mg c/6-8 horas; Nolotil 575 c/6-8h), AINE (Dexketoprofeno 25mg/8 horas; naproxeno 500 mg/12h, etc), relajantes musculares (Diazepam 5mg/12h), corticoides (Dexametasona 4mg/24 h tres días y luego otros tres a días alternos si no hay respuesta) y si refractariedad usaremos analgésicos opiodes (tramadol 50 mg c/8h,etc). Se pueden combinar entre ellos.

Con Compromiso Neurológico

Considerar realizar RMN para valorar lesión y necesidad de cirugía según hallazgos.

Lumbalgia inflamatoria

Probable Espondiloartropatía

AINE (Naproxeno 500 mg c/12h, etorocoxib 90 mg/24h) y derivación a Reumatología si buen estado general.

Probable neoplasia: Ingreso hospitalario, estudio de imagen para tratar de identificar tumor primario y valorar alcance de lesión (TAC-RMN-Gammagrafía).

Probable Infección

Ingreso hospitalario, pruebas complementarias y tratamiento antibiótico IV dirigido.

Sospecha de otras patologías: Valoración por especialista correspondiente.

NOTA

- La más frecuente es la lumbalgia mecánica, pero hemos de reconocer la inflamatoria por la gravedad que puede enmascarar.

BIBLIOGRAFÍA

- Donnay Brisa G., Jiménez Murillo L., Roig García J.J., Montero Perez F.J. Lumabalgia aguda. Lumbociatica. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5 Edición. 2015. 105: 582-587.
- Sánchez Martín J. Lumabalgia Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 Octubre. 7 Edición. 2015. 11:117-120.

MONOARTRITIS

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La monoartritis es una sinovitis inflamatoria que afecta a una sola articulación. Puede producirse en cualquier localización articular, sin embargo, suele ser más frecuente en grandes articulaciones como hombros, caderas, rodillas y tobillos.

DIAGNÓSTICO

Clasificación según duración

- Aguda: Presentación brusca que evoluciona en horas o pocos días con una inflamación muy intensa.
- Subaguda: Presentación no explosiva con evolución a la cronicidad.
- Crónica: Duración de más 6 semanas.

Anamnesis

Pregunar por antecedentes familiares, de inmunosupresión, de viajes a zonas endémicas, características del dolor, localización y sintomatología sistémica.

Exploración física

- Movilidad articular: Si hay limitación en la movilidad suele ser por artritis; si por el contrario, la movilidad está conservada debemos descartar que el origen del dolor y de la inflamación se encuentra en estructuras vecinas como tendones, ligamentos o bolsas serosas.
- Examen cutáneo: Tumefacción, eritema local (típico de afectación de articulaciones superficiales), lesiones en mucosa oral-genital (Beçhet), vesículas/pústulas cutáneas (artritis gonocócica)...
- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

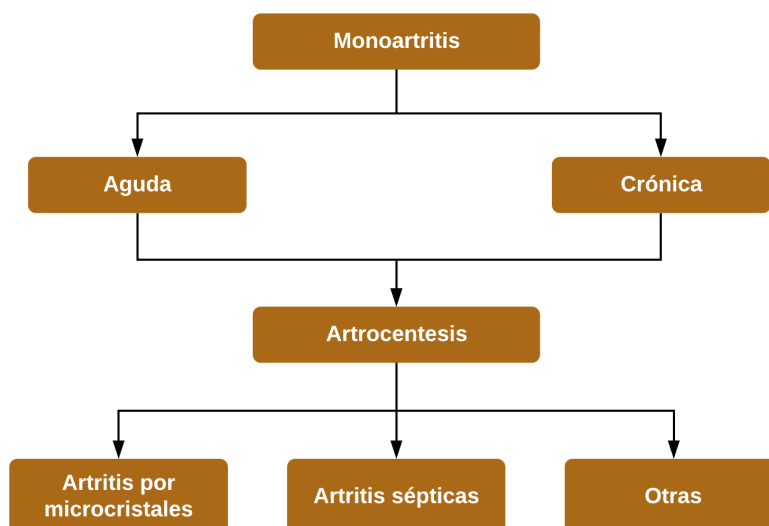
- Artrocentesis: Ante toda monoartritis hemos de realizar punción y análisis del líquido sinovial; valorando aspecto macroscópico-bioquímica-recuento- fórmula leucocitaria-búsqueda de cristales-si líquido muy inflamatorio Tinción de Gram urgente.

	N	NI	I	S	H
Viscosidad	Alta	Alta	Baja	Variable	Baja
Aspecto	Trasparente	Amarillo claro	Amarillo pajizo	Purulento	Sanguino-lento
Leucocitos	50-200	200-2.000	2.000-50.000	>50.000	Variable
PMN	<10%	<10 %	Variable	>90%	-
Glucosa (mg/ml)	80-100	95-100	80-100	50	Variable
Proteínas (g/dl)	1,3-1,8	3-3,5	>4	>4	Variable
Ejemplos		Artrosis Necrosis aséptica	AM AR Esp. Autoinm.	Artritis séptica	Hemofilia Depósito pirofosfat

- N: Normal NI: No inflamatoria I: Inflamatoria S: Séptico H: Hemorrágico AM: Artritis por microcristales AR: Artritis reumatoide - Esp: Espondiloartropatías - Analítica: Bioquímica básica (con reactantes de fase aguda), hemograma y sistemático de orina en un manejo urgente. Analítica más

completa que incluya serologías o marcadores de autoinmunidad para detectar las etiologías infecciosa y reumática. - Pruebas de imagen: Radiología simple de la articulación en cuestión para poder detectar cambios degenerativos (osteofitos, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral...), condrocalcinosis. Otras serían ecografía (sobre todo para valorar partes blandas y guiar punciones), TAC, RMN.

Algoritmo diagnóstico



Artritis por microcristales: La **más frecuente**. Clínicamente indistinguibles entre ellas; el análisis del líquido sinovial permite su diferenciación. Suele afectar a articulaciones de miembros inferiores, sobre todo en la gota y condrocalcinosis.

Artritis séptica: **Primera a considerar por gravedad** (compromiso vital). Brusca, muy dolorosa, con fiebre y escalofríos. Relación con infecciones previas (cutánea, urinaria, respiratoria...) y con factores de riesgo (DM, corticoides, manipulación articular...). Valorar puerta de entrada. Suele afectar a grandes articulaciones

Criterios De Ingreso

- Artritis séptica.
- Sospecha de enfermedad sistémica.

TRATAMIENTO

- Artritis por microcristales: Evitar diuréticos, aspirina y alcohol. Usaremos colchicina, AINEs (diclofenaco, ketoprofeno), corticoides-ACTH (si refractariedad o contraindicación a AINEs). Se podría plantear la necesidad de infiltraciones locales.
- Artritis gotosa: Mismo tratamiento, pero evitar suprimir tratamiento de base y no instaurar tratamiento hipouricemiante.
- Artritis séptica: Hospitalización. Inicio tratamiento empírico con Cloxacilina y ceftriaxona; posteriormente, antibiótico IV dirigido según cultivo. Drenaje e inmovilización de la articulación.

NOTA

- Ante toda monoartritis artrocentesis y análisis del líquido sinovial. Primera causa a descartar por gravedad es infecciosa, a pesar de que la causa más frecuente sea la artropatía por microcristales.

BIBLIOGRAFÍA

- Ballina García, F.J. Monoartritis. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 19: 105-109.
- Labandeira Pazos, J; Sobrado Ejo, R. Monoartritis aguda. Libro electrónico de Temas de Urgencias. Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Urgencias HVC.
- Sangüenza Gómez, CI. Análisis del líquido sinovial. Manual SER de enfermedades reumáticas. 2018. 43: 243.

POLIARTRITIS

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Poliartritis, en un sentido estricto sería, la sinovitis de ≥ 4 articulaciones; y en caso de afectación de 2-3 articulaciones hablaríamos de oligoartritis. Sin embargo, esta clasificación tiene poca relevancia clínica, por lo que podríamos considerar poliartritis a partir de 2 articulaciones afectas. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica diaria.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

- Historia familiar.
- Edad y sexo: Algunos ejemplos.
 - Varones jóvenes: Espondiloartropatía.
 - Mujeres jóvenes: Conectivopatías y artritis víricas.
 - Mujeres mediana edad: Artritis reumatoide.
 - Mayores 60 años: Polimialgia reumática.
- Antecedentes inmediatos: Infecciones recientes, contactos sexuales, diarrea...
- Inicio y evolución clínico:
 - Aguda: Duración de menos de 6 semanas, suele orientar a proceso infeccioso o por microcristales.
 - Crónica: Duración de más 6 semanas, orienta a proceso autoinmune o cuadros neoplásicos.
 - Distribución:

SIMÉTRICA	ASIMÉTRICA
Artritis reumatoide (AR)	Espondiloartropatías.
Artrosis.	Artropatía por ácido úrico-pirofosfato cálcico.
Artritis vírica.	Artritis bacteriana. Enfermedad de Lyme. Endocarditis bacteriana.
LES/Polimialgia reumática/ Enfermedad mixta de tejido conectivo.	Reumatismo palindrómico.
Osteoartropatía hipertófica.	Síndromes paraneoplásicos.

- Secuencia afectación articular - Aditivo: Afectación de nuevas articulaciones con anteriores afectas. - Migratorio: Afectación de nuevas articulaciones y anteriores con mejoría - Intermitente: Remisión completa entre los episodios. - Localización - Manos y pies: - Metacarpofalángicas: AR. - Primer dedo de pie: Artritis gotosa. - Interfalángica proximal: AR/ Nódulos de Bouchard de artrosis - Interfalángica distal: Artritis psoriásica/ Nódulos de Heberden de artrosis. - Carpos: AR. - Caderas, artritis en miembros inferiores: Espondiloartropatías.

- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

- Artrocentesis: Valorando aspecto macroscópico-bioquímica-recuento y fórmula leucocitaria-búsqueda de cristales. (Ver capítulo monoartritis).
- Analítica: Bioquímica básica (con reactantes de fase aguda y niveles de ácido úrico), hemograma y sistemático de orina en un manejo urgente. Analítica con serologías o marcadores de autoinmunidad para detectar las etiologías infecciosa y reumática.
- Pruebas de imagen: Radiología simple.

- Artrosis: Osteofitos, esclerosis subcondral, disminución de espacio articular...
- Artritis reumatoide: Erosiones.
- Artropatías microcristalinas: Calcificaciones de cartílago y partes blandas (Pirofosfato cálcico, hidroxipatita). Erosiones en sacabocado (Ácido úrico).

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- Sospecha de artritis séptica: Raro.
- Sospecha de enfermedad sistémica.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: Reposo relativo de la articulación.
- Según causa:
 - Séptica: Ingreso y antibioterapia dirigida.
 - Microcristalina: No modificar ni iniciar pauta hipouricemiante. Analgesicos (Nolotil 575 mg c/6-8h) y/o antiinflamatorios (Naproxeno 500 mg 1c/12 h o ibuprofeno 600 mg c/6h) y Colchicina 1 mg c/24.
 - Procesos reumatológicos (AR/ EA...): AINE (Naproxeno 500 mg c/12h) y derivación a consultas de reumatología si buen estado general.
 - Sospecha de proceso sistémico no filiada: Ingreso para estudio.

NOTA

- Muchas enfermedades reumatológicas pueden presentarse como poliartritis.

BIBLIOGRAFÍA

- Gómez Centeno A. Poliartritis. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 20: 109-115.
- Zalba Marcos S. Poliartritis aguda. Libro electrónico de Temas de Urgencias. Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Urgencias HVC.
- Jiménez Murillo L., Muñoz Ávila J., Aparicio Sánchez J., Caracue Ruíz M.A., Collantes Estévez E. Poliartritis. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5 Edición. 2015. 107: 592-594.

POLIMIALGIA REUMÁTICA

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La polimialgia reumática (PMR) es un trastorno inflamatorio de etiología desconocida, caracterizado por dolor y rigidez matutina que afecta a las cinturas escapular y pelviana y a la región cervical. Es más frecuente por encima de los 50 años y sobre todo, en las mujeres.

DIAGNÓSTICO

Clínica

Los síntomas suelen tener una aparición rápida, en pocos días e incluso, de forma brusca durante la noche. Es muy característico que estos pacientes tengan dificultad para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Puede comenzar de forma unilateral, pero conforme avanza la enfermedad, es frecuente que se haga bilateral.

- Dolor:
 - Inflamatorio.
 - Peor al levantarse y mejora parcialmente a lo largo del día.
 - Suele afectar a cuello, cintura escapular, cintura pélvica, caderas y muslos.
- Rigidez
 - Matutina.
 - Duración entre 30-60 minutos.
- Otros
 - Febrícula.
 - Fatiga.
 - Síndrome general (astenia, anorexia y pérdida de peso).

Exploración física

Restricción al movimiento activo de las cinturas escapular y pelviana sin inflamación articular clínicamente observable. El movimiento pasivo es, en la mayoría de las ocasiones, prácticamente normal.

Pruebas complementarias

- Bioquímica: Valorar reactantes de fase aguda, sobre todo la PCR, que suele encontrarse elevada.
- Hemograma: Valorar VSG que suele presentar valores >40 mmHg.
- Ecografía: Para valorar bursitis subacromial y tenosinovitis bicipital si dolor en cintura escapular y bursitis trocantérica si dolor en cintura pelviana.
- RMN: Indicada en PMR con presentación atípica o pacientes con reactantes de fase aguda normales.

En general, la mejor forma de diagnosticar una PMR en Urgencias sería una clínica compatible junto con marcadores de fase aguda elevados (PCR y VSG). Éstos últimos también son útiles para el seguimiento, dado que suelen elevarse en caso de recaídas.

Criterios de clasificación

Criterios imprescindibles	Criterios opcionales
Edad $\geq$ 50 años.	Rigidez matutina $>$ 45 minutos (2 puntos)
Omalgia bilateral.	Dolor o limitación en cintura pelviana (1 punto)
Aumento de PCR.	Ausencia de FR y/o Ac Antipéptido citrulinado (2 puntos)
Aumento de VSG.	Ausencia de dolor en articulaciones periféricas (1 punto)

Una puntuación >4 puntos es diagnóstico de PMR.

Podríamos considerar también datos ecográficos, que valorarían la presencia de inflamación en estructuras de la cintura escapular y pelviana (de forma unilateral y bilateral) añadiendo un punto por cada una de las dos formas y considerándose diagnóstico si a la tabla anterior junto con las alteraciones ecográficas se obtuviera una puntuación > 5 .

Criterios de ingreso

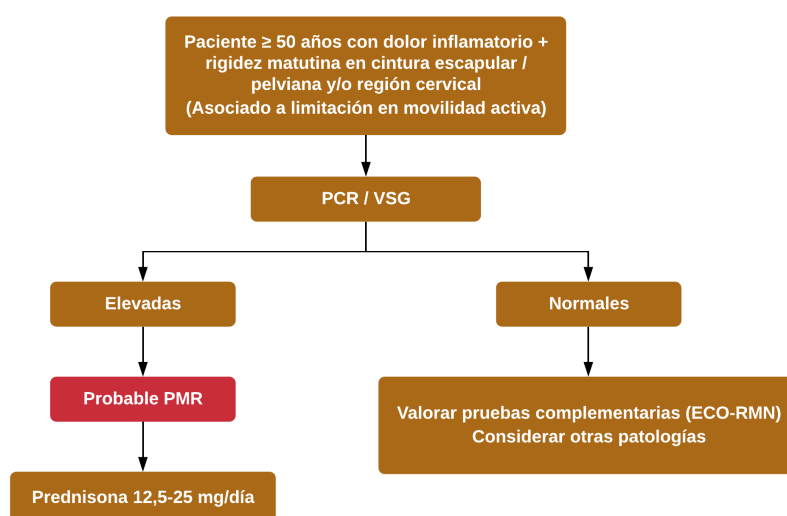
- Mal estado general del paciente.
- Refractariedad al tratamiento habitual.
- En caso de duda diagnóstica.

TRATAMIENTO

De elección **glucocorticoides** como prednisona a dosis inicial de 12,5-25 mg/día. Los pacientes suelen presentar una mejoría espectacular en la primera semana de tratamiento e incluso muchos, en las primeras 24 horas. Después de 3-4 semanas de tratamiento, se recomienda iniciar pauta descendente a ritmo de 2,5 mg cada dos semanas hasta 10 mg/día; y posteriormente, descenderemos 1-1,25 mg/mes hasta suprimir el tratamiento que suele necesitarse durante al menos 1-2 años.

En algunos casos, hemos de mantener dosis bajas de corticoide de manera indefinida (2,5-5 mg/día) para evitar las recaídas.

NOTA



Algoritmo resumen de actitud ante PMR.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Gay Matecón, M.A. Arteritis de células gigantes. Polimialgia reumática. Arteritis de Takayasu. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 88: 522- 530.
- García Arias, R.L. Martín Gutierrez, J. Claudia Díaz, M.Fernández-Avila, D. Polimialgia reumática. Revista Colombiana Reumatología. 2015. 22: 104-109.

SEMIOLOGÍA DEL PACIENTE REUMATOLÓGICO

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Se estima que en España padece una enfermedad reumatológica alrededor de un 23% de la población, representando un 10% de las urgencias hospitalarias, un 15% de las consultas de atención primaria y hasta un 19% de las incapacidades laborales. Son una de las patologías más prevalentes en nuestro medio y por tanto, hemos de conocer cómo valorar a estos pacientes.

DIAGNÓSTICO

Los principales síntomas que nos encontramos son:

- Dolor: Se valora de manera similar al que podemos encontrar en otros órganos.
 - Localización: Óseo, articular, partes blandas. Los dolores no articulares habitualmente se manifiestan en movimientos activos, pero no en los pasivos. Hemos de tener en cuenta que el dolor generado en estructuras superficiales (pequeñas articulaciones de manos-pies, carpos, codos, tobillos, rodillas) tiende a ser localizado; mientras que el generado en estructuras profundas (hombros, columna vertebral, caderas y sacroilíacas) suele ser insidioso, continuo y mal definido.
 - Desencadente.
 - Maniobras que empeoren o que alivien el dolor.
 - Duración: Agudo, subagudo y crónico.
 - Modo de presentación: Episódico, aditivo (se van sumando dolores en otras localizaciones), migratorio (cambia la localización del dolor).
 - Tipo:
 - Mecánico: Empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Puede presentar rigidez, habitualmente tras el reposo de pocos minutos.
 - Inflamatorio: Más continuo, en reposo y con exacerbaciones nocturnas. Acompañado de rigidez, habitualmente matutina y de más de 1 hora de duración.
 - Intensidad.
 - Repercusión sobre calidad de vida.
- Tumefacción: Aumento de volumen de una estructura que indica proceso inflamatorio. Sólo se detecta cuando afecta a estructuras superficiales.
- Calor y enrojecimiento: Indicativos de proceso inflamatorio. El segundo suele relacionarse con procesos inflamatorios graves.
- Rigidez: Sensación temporal, percibida tras periodo de inactividad prolongado, de dificultad para llevar a cabo un movimiento. En general, los procesos inflamatorios se acompañan de rigidez con una duración superior a una hora mientras que los procesos mecánicos suelen presentar rigidez de corta duración.
- Impotencia funcional: Limitación en la movilidad de una estructura afecta por el dolor que aparece con el movimiento de ésta o por la rigidez asociada.
- Deformidad: Rara en fases iniciales, por lo que no es un motivo frecuente de consulta. No obstante, en fases avanzadas de la enfermedad, sobre todo si no está bien controlada es un hallazgo relativamente frecuente.

TRATAMIENTO

En el manejo del dolor reumatológico, al igual que cuando nos enfrentamos a dolor de otra

localización, debemos seguir una actitud escalonada:

- Analgésicos periféricos: En general tienen menores efectos que los AINE y últimos estudios revelan que sus beneficios podrían ser más bien pocos.:
 - Paracetamol: 500-650 mg/4 h ó 1g/6-8 h. No superando 4g/día. Precaución en pacientes con hepatopatía grave o alcohólicos.
 - Metamizol (Nolotil): 500-1000 mg/4-8h. No superando 6g/día. Precaución en anemia aplásica.
- AINE: Siguen siendo los más empleados en el tratamiento del dolor e inflamación leve-moderado. No obstante, no son recomendables en tratamientos crónicos, en pacientes ancianos y con comorbilidades por sus efectos secundarios sobre el tracto gastrointestinal y riesgo cardiovascular. Se recomienda asociar un IBP, sobre todo en personas mayores de 65 años con comorbilidades.
 - Ibuprofeno: 600 mg/6h ó 800 mg/8 h. No superando 2,4/día.
 - Dexibuprofeno: 300 mg/8-12 horas. No superando 1,2 g/día.
 - Naproxeno: 500 mg/12 h. No superando 1g/día.
 - Celecoxib: 200 mg/12 h. No superando 400 mg/día. Sobre todo si HTA o ERC.
- Opioides: Son los analgésicos más potentes. Se reservan para dolor que no se controla con los anteriores.
 - Tramadol: Si comprimidos de liberación inmediata 50-100 mg/6-8h (máximo 400 mg/día). Si comprimidos de liberación retardada 50-100 mg/12 h, no superando 400 mg/día.
 - Tapentadol: En paciente que no tomen otros opiáceos se administrará 50mg/12h. Si ya está en tratamiento con opiáceos se recomienda aumentar gradualmente con dosis de 50 mg/12h cada 3 días (máxima 500mg/24h).
 - Oxycodona-Naloxona.

Si el dolor es muy intenso, podríamos optar por medicación más potente si recurrir a la escalera analgésica ("Ascensor terapéutico").

NOTA

- Muy importante reconocer aquellos síntomas y signos que orienten a proceso inflamatorio, fundamentalmente el dolor y cómo manejarlo.

BIBLIOGRAFÍA.

- Larrosa Padró M. Anamnesis y exploración física de las enfermedades reumáticas. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 17: 93-98.
- Díaz González F. Analgésicos periféricos. AINE. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 52: 297-302.
- Revenga Martínez M. Opioides. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 53: 303-307.